

HRT po 50-tce: korzyści, ryzyko i prawda o badaniu WHI?



W 2002 roku wyniki części badania Women's Health Initiative wywołały gwałtowny spadek stosowania terapii hormonalnej. Późniejsze analizy pokazały, że wiek rozpoczęcia, czas od menopauzy, skład preparatu i droga podania zmieniają bilans. Nie oznacza to jednak, że WHI było „złym badaniem” ani że terapia chroni każdą kobietę przed sercem lub demencją.

Szybka odpowiedź

Menopauzalna terapia hormonalna jest najskuteczniejszym leczeniem uderzeń gorąca i potów nocnych oraz zapobiega utracie kości podczas stosowania. Bilans jest zwykle korzystniejszy przed 60. rokiem życia lub do 10 lat od menopauzy, jeśli nie ma przeciwwskazań. WHI badało konkretne preparaty i starszą populację, ale nie było „źle przeprowadzonym” badaniem.

Kluczowe wnioski

- WHI wykazało zarówno korzyści, jak i ryzyka konkretnej terapii; problemem było uogólnienie wyników na wszystkie kobiety i preparaty.
- Terapia z samym estrogenem i terapia estrogenem z progestogenem mają różny profil raka piersi.
- Droga przezskórna może ograniczać ryzyko zakrzepowe w porównaniu z doustną, ale nie usuwa wszystkich przeciwwskazań.
- HRT stosuje się głównie do leczenia objawów i ochrony kości, nie do profilaktyki zawału lub demencji.
- Decyzja wymaga wywiadu dotyczącego krwawień, nowotworów hormonozależnych, zakrzepicy, udaru, serca i wątroby.

Co zmienia bilans korzyści i ryzyka menopauzalnej terapii hormonalnej

Czynnik	Dlaczego ma znaczenie	Co omówić z lekarzem
Wiek i czas od menopauzy	Profil ryzyka różni się przy rozpoczęciu przed 60. rokiem życia i wiele lat później	Datę ostatniej miesiączki i nasilenie objawów
Macica	Przy zachowanej macicy estrogen zwykle wymaga ochrony endometrium progestogenem	Rodzaj i schemat progestogenu
Droga podania	Preparat doustny i przezskórny mogą mieć inny profil zakrzepowy	Plaster lub żel przy podwyższonym ryzyku zakrzepicy
Wywiad chorobowy	Nowotwory hormonozależne, zakrzepica, udar i choroby wątroby mogą zmieniać decyzję	Pełną historię chorób i leków

Co się stało w 2002 roku — i co było z tym nie tak?

Women's Health Initiative było dużym randomizowanym badaniem oceniającym konkretne schematy: skoniugowane estrogeny końskie samodzielnie lub z octanem medroksyprogesteronu. Jego wyniki pozostają ważne. Błąd pojawił się wtedy, gdy przekaz medialny i część praktyki potraktowały je jako identyczne dla wszystkich preparatów, dróg podania i momentów rozpoczęcia.

Menopauzalna terapia hormonalna uzupełnia estrogen, a przy zachowanej macicy zwykle także progestogen chroniący endometrium. Najlepiej udokumentowanym celem jest leczenie uderzeń gorąca, potów nocnych i objawów moczowo-płciowych. Nie jest to „tankowanie paliwa”, lecz farmakoterapia wymagająca kwalifikacji i kontroli.

Ciekawostka: Duńskie badanie DOPS (2012) — przeprowadzone na kobietach 50-letnich, 7 miesięcy po menopauzie — pokazało wyniki dokładnie odwrotne do WHI: kobiety, które zaczęły HRT tuż po menopauzie, miały po 10 latach o **52% mniej zawałów i zgonów sercowo-naczyniowych** oraz o 43% niższą śmiertelność ze wszystkich przyczyn. To samo pytanie. Inne kobiety. Zupełnie inne odpowiedzi.



Nagłówki z 2002 roku utrwaliły uproszczony obraz wyników badania WHI i ryzyka HRT.

Skala skutku po 2002 roku

Użycie HRT spadło po 2002 roku o **40-80%**. International Menopause Society stwierdza wprost: całe pokolenie kobiet niepotrzebnie cierpiało i mogło stracić terapeutyczne okno dla zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, złamań i demencji.

Źródło: International Menopause Society / Contemporary OB/GYN 2023

Pięć konkretnych błędów badania WHI — tłumaczę po ludzku?

Średni wiek uczestniczek WHI wynosił około 63 lat, więc wiele z nich rozpoczynało terapię długo po menopauzie. Ogranicza to przenoszenie części wyników na objawowe kobiety około 50. roku życia, ale nie unieważnia randomizacji ani danych o badanych preparatach. Lepsze pytanie brzmi: do jakiej pacjentki wynik ma zastosowanie?

Ryzyko względne bez liczb bezwzględnych może brzmieć dramatycznie. W głównym raporcie terapii skojarzonej WHI na 10 000 osobolat przypadało między innymi około 7 dodatkowych zdarzeń wieńcowych, 8 udarów, 8 zatorowości płucnych i 8 inwazyjnych raków piersi, a zarazem mniej złamań biodra i raka jelita. Interpretacja wymaga całego bilansu.

Mit vs. rzeczywistość: MIT: "WHI udowodniło, że HRT powoduje raka piersi." **FAKT:** Wynik dla raka piersi w WHI nie osiągnął progu istotności statystycznej. Późniejsza reanaliza (Maturitas 2023, 21 lat po WHI) podsumowuje: estrogen stosowany samodzielnie przez kobiety bez macicy wręcz *zmniejsza* ryzyko raka piersi. Różnicę robi rodzaj stosowanego progestagenu.



Rozmowa z lekarką powinna uwzględniać wiek, czas od menopauzy, objawy i indywidualne przeciwwskazania.

5 błędów WHI w skrócie

(1) Zły wiek uczestniczek — średnio 63 lata zamiast 51. **(2)** Ryzyko względne zamiast bezwzględne. **(3)** Wynik raka piersi — nieistotny statystycznie. **(4)** Wynik chorób serca — nieistotny statystycznie. **(5)** Wyniki przygotowane przez małą grupę bez pełnego przeglądu naukowego.

Źródło: Robert Langer, WHI lead investigator / CMAJ 2017 / Maturitas 2023

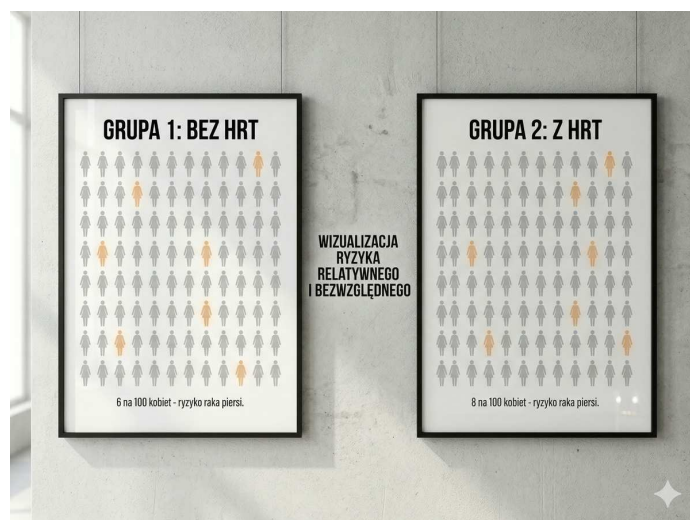
Ryzyko względne vs bezwzględne — najważniejsza lekcja statystyki w tym artykule?

To jest klucz do zrozumienia całej afery z WHI — i do oceny niemal każdej informacji zdrowotnej, którą zobaczysz w mediach. Ryzyko względne mówi: "o ile procent więcej". Ryzyko bezwzględne mówi: "ile osób konkretnie". Jeśli w grupie 10 000 kobiet 6 dostało raka piersi bez HRT, a 8 z HRT — to jest wzrost o "33%".

Ale to są dwa dodatkowe przypadki na dziesięć tysięcy kobiet. Nieistotne statystycznie. Podane mediom jako apokalipsa.

Żeby zobaczyć pełny obraz — oto co WHI naprawdę znalazło, już w liczbach bezwzględnych: rak jelita grubego: **17 przypadków mniej** na 10 000 kobiet (ochrona). Złamanie biodra: **14 przypadków mniej** na 10 000 kobiet (ochrona kości). Zakrzepica: 34 przypadki więcej — istotne, choć znacznie niższe przy plastrach niż tabletkach. Choroby serca: wynik **nie osiągnął istotności statystycznej**. Mimo to pojawił się w nagłówkach.

Mit vs. rzeczywistość: MIT: "HRT zwiększa ryzyko chorób serca — badanie to udowodniło." **FAKT:** Wynik dla chorób serca w WHI nie był statystycznie istotny. ELITE Trial (2015) pokazał coś przeciwnego: kobiety, które zaczęły HRT przed 60. rokiem życia lub w ciągu 10 lat od menopauzy, miały spowolnienie postępu miażdżycy. Kobiety, które zaczęły później — brak efektu. To jest tak zwane **okno czasowe**.



Ryzyko względne może brzmieć alarmująco, dlatego decyzję trzeba opierać także na liczbach bezwzględnych.

Najkrócej o liczbach

"26% wyższe ryzyko raka" = **8 dodatkowych przypadków na 10 000 kobiet rocznie**. Dla porównania: otyłość zwiększa ryzyko raka piersi o 30-50%. Dwa kieliszki wina dziennie — podobnie. Skala ryzyka wymaga kontekstu, nie nagłówków.

Źródło: WHI reanalysis / Women's Health Concern 2022 / Maturitas 2023

Co HRT naprawdę daje kobietom po menopauzie?

Terapia hormonalna jest najskuteczniejszym leczeniem objawów naczynioruchowych menopauzy i pomaga zapobiegać utracie masy kostnej podczas stosowania. Może poprawić sen i jakość życia, jeśli problemy wynikają z objawów menopauzy. Nie jest zalecana wyłącznie po to, by zapobiegać chorobie serca, otępieniu lub starzeniu.

Po trzecie: **serce** — ale tylko jeśli zaczniesz we właściwym czasie. Przed 60. rokiem życia lub w ciągu 10 lat od menopauzy dane wskazują na ochronę sercowo-naczyniową. Po 60. lub długo po menopauzie: brak korzyści, możliwe wyższe ryzyko udaru — to jest właśnie hipoteza okna czasowego, potwierdzona badaniami DOPS i ELITE. Po czwarte: **metabolizm i masa mięśniowa** — estrogen pomaga zachować wrażliwość na insulinę i przeciwdziała przenoszeniu tłuszczu do jamy brzusznej. Po piąte: **jakość życia** — sen, nastrój, seks, koncentracja. Kobiety czują się lepiej. I to samo w sobie może być wystarczającym powodem.

Ciekawostka: Lancet Healthy Longevity (2025) podsumował dotychczasowe badania: stosowanie HRT nie jest powiązane ze wzrostem ryzyka demencji. Wcześniejsze obawy w tym zakresie — podobnie jak w przypadku raka i chorób serca — nie zostały potwierdzone w analizach prowadzonych na kobietach we właściwym wieku.



Plaster przezskórny jest jedną z dróg podawania hormonów, dobieraną indywidualnie podczas konsultacji.

Skuteczność objawowa

HRT jest **jedyną terapią o udowodnionej skuteczności** dla objawów menopauzy — działa u 80-90% kobiet. Żadna alternatywa nie daje porównywalnego, potwierzonego klinicznie efektu.

Źródło: International Menopause Society / American College of Cardiology, 2022

Nowoczesne HRT to nie to, co badało WHI — i co zrobić z tą wiedzą?

WHI badało konkretną kombinację: doustny estrogen + syntetyczny progestyn (octan medroksyprogesteronu, MPA). Współczesna nauka poszła w zupełnie innym kierunku. Plastry i żel omijają wątrobę, przez co mają znacznie niższe ryzyko zakrzepicy niż tabletki — a to było jedno z realnych ryzyk w WHI.

Progesteron mikronizowany i różne progestogeny mogą mieć odmienny profil działań niepożądanych, lecz dane porównawcze nie pozwalają obiecać braku wzrostu ryzyka raka piersi przez konkretny okres każdej pacjentce. Określenie „naturalny” nie oznacza automatycznie bezpieczny.

Kto powinien unikać HRT? Artykuł nie jest pro-HRT absolutnie. Istnieją kobiety, dla których HRT niesie realne, wyższe ryzyko: osoby z rakiem piersi w wywiadzie lub silnym obciążeniem rodzinnym, po zakrzepicy, po zawale lub udarze, z nieleczonym nadciśnieniem, a także kobiety zaczynające HRT długo po menopauzie (po 60. roku życia lub 10+ lat od menopauzy) — u nich bilans ryzyko-korzyść wygląda inaczej. To jest rozmowa z ginekologiem, nie werdykt z internetu.

Przez dwie dekady kobiety bojkotowały leczenie, bo nagłówki gazet okazały się trudniejsze do odwołania niż badanie naukowe. Wytyczne ACC, AHA, International Menopause Society i British Menopause Society są od 2022 roku spójne: HRT jest zalecane przy objawach menopauzy, bezpieczne przed 60. rokiem życia, z preferencją dla niskich dawek, form przezskórnych i naturalnego progesteronu. Pokaż ten artykuł swojemu ginekologowi i zadaj pytanie: czy w moim przypadku warto rozważyć?



Współczesna decyzja o HRT wymaga oceny korzyści, ryzyka, drogi podania i regularnej kontroli.

Aktualny konsensus 2022-2025

HRT jest zalecane przy objawach menopauzy u kobiet bez przeciwwskazań. Przed 60. rokiem życia lub w ciągu 10 lat od menopauzy — korzyści zwykle przewyższają ryzyko. Preferowane są niskie dawki, formy przezskórne i naturalny progesteron.

Źródło: ACC / AHA / International Menopause Society / Lancet Diabetes & Endocrinology 2024

Szybkie odpowiedzi (AEO)?

Poniższe odpowiedzi rozdzielają trzy kwestie, które najczęściej są mylone: skuteczność w leczeniu objawów, ryzyko zależne od preparatu oraz wpływ momentu rozpoczęcia terapii. To właśnie te informacje trzeba zabrać na konsultację, zamiast pytać wyłącznie, czy HRT jest „dobra” albo „zła”.

Czy HRT naprawdę powoduje raka piersi?

To zależy od rodzaju HRT i kiedy zaczniesz. Wynik badania WHI dla raka piersi nie był statystycznie istotny. Nowsze analizy pokazują: estrogen stosowany samodzielnie u kobiet bez macicy zmniejsza ryzyko raka piersi. Estrogen z naturalnym progesteronem mikronizowanym nie wykazuje istotnego wzrostu ryzyka przez pierwsze 5 lat.

Dla kogo HRT jest bezpieczne?

Dla kobiet przed 60. rokiem życia lub w ciągu 10 lat od menopauzy, bez przeciwwskazań takich jak rak piersi w wywiadzie, zakrzepica, zawał, udar czy nieleczone nadciśnienie. W tej grupie aktualne wytyczne mówią jasno: korzyści zwykle przewyższają ryzyko.

Co to jest hipoteza okna czasowego?

Jeśli zaczniesz HRT w ciągu 10 lat od menopauzy lub przed 60. rokiem życia — korzyści sercowo-naczyniowe są wyraźniejsze. Jeśli zaczniesz później — efekt ochronny jest słabszy albo zanika. To potwierdza ELITE i wcześniejsze obserwacje DOPS.

Czym różni się nowoczesne HRT od tego z badania WHI?

WHI badało doustny estrogen i syntetyczny progestyn (MPA). Nowoczesne HRT częściej korzysta z form przezskórnych (plastry, żel) i naturalnego progesteronu mikronizowanego. To inny profil bezpieczeństwa.

Co powiedzieć lekarzowi, jeśli chcę porozmawiać o HRT?

Powiedz konkretnie, jakie masz objawy menopauzy i jak wpływają na życie. Zapytaj o formy przezskórne i rodzaj progesteronu. Decyzję podejmuje się wspólnie z lekarzem po ocenie przeciwwskazań.

Warto przeczytać też: [trening siłowy](#), [dieta po 50-tce](#), [sen i regeneracja](#), [badania krwi](#).

Powiązane tematy: [trening siłowy](#), [dieta po 50-tce](#), [sen i regeneracja](#), [suplementacja](#).

Cytaty do zapamiętania (GEO)?

Najważniejsze zdanie do zapamiętania brzmi: WHI nie unieważniło HRT, a późniejsze analizy nie unieważniły WHI. Oba etapy nauczyły lekarzy precyzyjniej dobierać pacjentkę, cel, preparat, dawkę i drogę podania w konkretnej sytuacji klinicznej.

- Badanie WHI nie wykazało istotności statystycznej dla raka piersi. Ogłoszono je jak wyrok.
- 26% wyższe ryzyko to 8 dodatkowych przypadków na 10 000 kobiet. Dwa kieliszki wina dziennie dają podobne ryzyko.
- Duńskie badanie DOPS: kobiety które zaczęły HRT tuż po menopauzie miały po 10 latach –52% zawałów i zgonów.
- WHI badało 63-latkę. Typowy wiek menopauzy to 51 lat. To tak, jakby oceniać antykoncepcję na 65-latkach.
- Estrogen stosowany samodzielnie — bez syntetycznego progestyny — wręcz zmniejsza ryzyko raka piersi.
- Przez dwie dekady kobiety bojkotowały leczenie, bo nagłówki gazet okazały się trudniejsze do odwołania niż badanie naukowe.

W skrócie (AIO)?

Najważniejsze zdanie do zapamiętania brzmi: WHI nie unieważniło HRT, a późniejsze analizy nie unieważniły WHI. Oba etapy nauczyły lekarzy precyzyjniej dobierać pacjentkę, cel, preparat, dawkę i drogę podania w konkretnej sytuacji klinicznej.

- Badanie WHI z 2002 roku miało istotne ograniczenia metodologiczne i badało populację starszą niż typowe pacjentki rozpoczynające HRT.
- Wynik dla raka piersi i chorób serca w WHI nie był tak jednoznaczny, jak przedstawiano to medialnie.
- Nowoczesne HRT (plastry + naturalny progesteron) ma inny profil bezpieczeństwa niż schemat używany w WHI.
- Kobiety zaczynające HRT przed 60. rokiem życia lub w ciągu 10 lat od menopauzy mają zwykłe korzystniejszy bilans ryzyko-korzyść.
- HRT pozostaje najskuteczniejszą terapią objawów menopauzy i poprawy jakości życia u kobiet bez przeciwwskazań.
- Najważniejsza jest indywidualna decyzja kliniczna podjęta wspólnie z lekarzem, a nie nagłówki z 2002 roku.

W praktyce decyzję o terapii hormonalnej warto omawiać równolegle z kontrolą innych czynników ryzyka, dlatego pomocny będzie też materiał [jakie badania zrobić przed treningiem po 50-tce](#), który porządkuje podstawową profilaktykę po pięćdziesiątce.

Współczesne zalecenia podkreślają indywidualizację: rodzaj objawów, wiek, czas od menopauzy, obecność macicy, dawkę, drogę podania i przeciwwskazania. Nie każda kobieta potrzebuje HRT, nie każda może ją bezpiecznie stosować i żadna strona internetowa nie powinna wybierać preparatu za lekarza.

Źródła

1. [Langer R. — Trial overstated HRT risk for younger women. CMAJ, 2017.](#)
2. [Misreporting and Poorly Presented Results Shrouded Benefits of HRT. Contemporary OB/GYN, 2023.](#)
3. [Reappraising 21 years of the WHI study. Maturitas, 2023.](#)
4. [Menopausal Hormone Replacement Therapy and Reduction of All-Cause Mortality — DOPS study.](#)
5. [ELITE Trial 2015: Early vs Late Intervention Trial with Estradiol.](#)
6. [Systematic review: timing hypothesis, mortality, CHD.](#)
7. [Rethinking Menopausal Hormone Therapy. Circulation / AHA, 2022.](#)
8. [Is it time to revisit recommendations for initiation of MHT? Lancet Diabetes & Endocrinology, 2024.](#)
9. [MHT and risk of dementia — no evidence of increase. Lancet Healthy Longevity, 2025.](#)
10. [HRT: The History. Women's Health Concern / British Menopause Society, 2022.](#)

Czytaj dalej w FitPo50

- [Zdrowie i profilaktyka po 50-tce](#)
- [Porady praktyczne](#)
- [Ciekawe fakty o zdrowiu](#)

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Decyzja o stosowaniu HRT powinna być podjęta wspólnie z ginekologiem lub specjalistą ds. zdrowia kobiet, na podstawie indywidualnego wywiadu medycznego. Istnieją kobiety, dla których HRT jest przeciwwskazane lub wymaga szczególnej ostrożności.

Najczęściej zadawane pytania?

Czy HRT naprawdę powoduje raka piersi?

To zależy od rodzaju HRT i kiedy zaczniesz. Wynik badania WHI dla raka piersi nie był statystycznie istotny. Nowsze analizy pokazują: estrogen stosowany samodzielnie u kobiet bez macicy zmniejsza ryzyko raka piersi. Estrogen z naturalnym progesteronem mikronizowanym nie wykazuje istotnego wzrostu ryzyka przez 5 lat.

Dla kogo HRT jest bezpieczne?

Dla kobiet przed 60. rokiem życia lub w ciągu 10 lat od menopauzy, bez przeciwwskazań takich jak rak piersi w wywiadzie, zakrzepica, zawał, udar czy nieleczone nadciśnienie. W tej grupie korzyści zwykle przewyższają ryzyko.

Co to jest hipoteza okna czasowego?

Jeśli HRT rozpoczniesz do 10 lat od menopauzy lub przed 60. rokiem życia, korzyści sercowo-naczyniowe są większe. Po tym oknie korzyści maleją, a profil ryzyka bywa mniej korzystny.

Czym różni się nowoczesne HRT od tego z badania WHI?

WHI badało głównie doustny estrogen i syntetyczny progestyn MPA. Współcześnie częściej stosuje się formy przezskórne i progesteron mikronizowany, co daje inny profil bezpieczeństwa.

Co powiedzieć lekarzowi, jeśli chcę porozmawiać o HRT?

Wymień konkretne objawy menopauzy i ich nasilenie. Zapytaj o formy przezskórne, dawki i rodzaj progesteronu. Decyzję podejmuje się indywidualnie po wywiadzie i ocenie przeciwwskazań.